УРОК 6. СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА. НУТРИЦЕВТИКИ И СХЕМА РАБОТЫ.

Синдром Жильбера (СЖ) – это генетическое заболевание (носит наследственный характер и имеет пожизненное течение), при котором возникает хронический повышенный уровень общего и свободного (непрямого) билирубина – токсичного желтого пигмента, при отсутствии других патологий печени. Он может быть очень высоким и ничто не помогает его снизить.

При СЖ неактивен ген (UGT1A1), который отвечает за перевод непрямого билирубина в прямой, поэтому непрямой билирубин всегда повышен.

СЖ может быть проявлен полностью (7/7) или на 50% (6/7).

Непрямой билирубин – это токсичный билирубин и он должен нашей печенью переводиться в прямой билирубин и далее выводиться с желчью из нашего организма. Если этого не происходит, то человек имеет постоянную высокую токсическую нагрузку на печень. В результате чего страдает синтез желчи и микрофлора кишечника, что ведет к варикозу, геморрою, экземам, аллергиям, атопическому дерматиту и другим заболеваниям.

Мутация связана с теми, что неактивный ген приводит к подавлению фермента глюкуронизилтрансферазы: который и переводит непрямой билирубин (токсичный) в прямой (не токсичный).

В результате несвязанный билирубин полноценно не выводится из печени через желчь.

ЭТО ПРИВОДИТ К:

1. нарушению второй фазы детоксификации печени: неспособность справиться с токсинами, пестицидами, гормонами, стероидами, консервантами, фенолами и т.д.

2. накопление токсинов в печени, а следовательно их переход в глубокие ткани и органы, что приводит к появлению хронических и аутоиммунных заболеваний.

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ - диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UG T1) в любой лаборатории, от 1 500 р.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА?

- 6/6 и менее – вариант нормы. Синдром Жильбера не подтвержден.
- 6/7 – гетерозиготное носительство. Могут проявляться некоторые симптомы болезни.
- 7/7 и более – генетическое подтверждение синдрома Жильбера. Следует ожидать развития симптомов заболевания.

СИМПТОМЫ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА:

- эпизодическое возникновение умеренной желтухи (окрашивания кожных покровов, слизистых, склер глаз в жёлтый цвет, особенно во время голоданий, недосыпах и переутомлении);
- периодические боли в правом подреберье, тошнота;
- усталость, раздражительность;
- сухость кожи, зуд, крапивница;
- непереносимость определенных лекарств и трав;
- гастроэнтерологические проблемы: вздутия, брожения, запоры.

ЧАСТО ЭТИ СИМПТОМЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ДРУГИХ ПАТОЛОГИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ, ПРИ ПАРАЗИТОЗАХ И ВЫРАЖЕННОМ ЗАСТОЕ ЖЕЛЧИ.

Поэтому ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ СЖ БЕЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА ПОСТАВИТЬ НЕВОЗМОЖНО!

НО! В АНАЛИЗАХ ПОВЫШАЕТСЯ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ БИЛИРУБИНА С ВЫРАЖЕННЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА (несвязанного с белками крови).

Остальные биохимические показатели крови и печеночные пробы остаются без изменений.

ПЛЮСЫ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА:

При СЖ ниже риск:

- сердечно-сосудистых заболеваний;
- хронических респираторных заболеваний;
- ниже индекс массы тела;
- выше скелетно-мышечная масса;
- длина теломер длиннее на 1 килобазу, т.е. люди с СЖ при адекватном образе жизни выглядят моложе своих сверстников.

Билирубин - это жёлчный пигмент, который окрашивает желчь в насыщенно жёлтый цвет.

СЖ проявляет себя в период с 5 до 30 лет и дальше остаётся на всю жизнь. Чаще болеют мужчины. Передача заболевания от родителей к ребенку возможна в 50% случаев.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕННОСТИ СИМПТОМОВ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА?

От вида СЖ. Есть два вида СЖ:

- 6/7 - облегчённая версия, нет симптоматики. Есть локальная мутация, которая не даёт клинических симптомов. Данный вид СЖ может проявляться легкой симптоматикой в виде пожелтения, но только при нездоровом образе жизни и питании.

- 7/7 - более тяжелая версия, сопровождается всей симптоматикой СЖ.

ЧТО МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ ПРИ СИНДРОМЕ ЖИЛЬБЕРА ПОПУТНО?

1. НЕРВНАЯ СИСТЕМА.

При повышении билирубина иногда может наблюдаться:

- ✓ тревожность;
- ✓ депрессия;
- ✓ панические атаки;
- ✓ снижается память;
- ✓ концентрация внимания.

2. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.

При СЖ выше риск развития АИТ (тиреоидита Хашимото).

! Без коррекции СЖ антитела к щитовидной железе снизить сложно!

ЧТО ДЕЛАТЬ? Снижаем билирубин + безмолочное и безглютеновое питание / аутоиммунный протокол питания и лечения.

3. ПЕЧЕНЬ

Снижаются детокс функция печени и способность клеток печени к восстановлению.

ПРИ СЖ ВЫШЕ РИСК:

- ✓ развития жирового гепатоза;
- ✓ желчнокаменной болезни.

4. ЖКТ.

Может усложняться работа поджелудочной железы, возникать дисбиоз кишечника. В результате пища плохо переваривается, возникают вздутие и нарушение перистальтики (запоры/диарея).

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧИ ПРИ СЖ ИСКЛЮЧИТЬ ВЕЩЕСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТА ГЛЮКУРОНОЗИЛТРАНСФЕРАЗЫ, А ТАКЖЕ МАКСИМАЛЬНО ЕГО СТИМУЛИРОВАТЬ.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ПРОВОЦИРУЮТ ОБОСТРЕНИЕ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА?

- стресс;
- интенсивные силовые нагрузки (лучше выбирать растяжки, пилатес, плаванье, любое легкое кардио, силовые нагрузки необходимо избегать, т.к. они дают резкий подъём билирубина);
- голодание (при СЖ нельзя голодать! Через сутки голодания и дольше - повышается билирубин);
- гормональная контрацепция;
- систематические употребление алкоголя в любых количествах, особенно при варианте мутации 7/7;
- паразитозы, вирусные и выраженные бактериальные пищевые токсикоинфекции;
- частое применение ряда лекарств: салицилаты, парацетамол, преднизолон, частые наркозы.

ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА ПРИ СЖ ПОЖИЗНЕННАЯ:

При (7/7) из рациона питания исключаются, а при (6/7) ограничиваются следующие продукты питания:

- алкоголь;
- кофе;
- продукты из какао;
- продукты с уксусом, маринады;
- жирные продукты (жирное мясо и рыба, копчености, субпродукты, жирные соусы);
- молоко, жирные молочные продукты;
- грибы;
- дрожжевые продукты;
- яйца, сваренные вкрутую;
- продукты из белой муки 1 сорта;
- чеснок и лук в сыром виде;
- при 7/7 также стоит ограничивать бобовые;
- орехи можно только вымоченные;
- курить при СЖ крайне нежелательно.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА БЛОКИРУЮТ ФЕРМЕНТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВОДИТ НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН В ПРЯМОЙ?

Все эти вещества при любом типе СЖ нужно избегать:

- фармацевтика: амфетамин, аспирин, ибупрофен (все НПВП), кетоконазол, мотилиум;
- гепабене;
- оральные контрацептивы;
- витамин А (ретинол);
- растения:
  - ✓ Расторопша (силимарин);
  - ✓ Saw Palmetto (серноа-пальма ползучая, основа Простамола);
  - ✓ Эхинацея;
  - ✓ Женьшень;
  - ✓ Галлат эпигаллокатехин (зеленый чай);
  - ✓ Чеснок;
  - ✓ Солодка;
  - ✓ Горец многоцветковый (Fo-ti);
- ингибиторы протонной помпы (омез, омепразол, рабепразол и т.д.);
- рафинированные углеводы;
- кетодиета;
- алкоголь.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА, СПОСОБСТВУЮТ АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТА ГЛЮКУРОНОЗИЛТРАНСФЕРАЗЫ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ПЕРЕВЕСТИ НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН В ПРЯМОЙ:

- все крестоцветные (проростки брокколи идеально, можно в виде добавки), брюссельская капуста, кейл, цветная капуста, зелень, спаржа;
- кверцетин (каперсы, гречка, красный лук, листовые овощи, томаты);
- куркумин (с жирной пищей), ресвератрол;
- глюкоза и фруктоза из фруктов, цитрусовые;
- розмарин;
- одуванчик;
- таурин (аминокислота для желчных кислот);
- д-глюкарат кальция (calcium d-glucarate);
- солярий (ультрафиолет, UVB свет для снижения билирубина);
- при СЖ показан регулярный приём гепатопротекторов:

  - ✓ омега-3;
  - ✓ альфа липовая кислота;
  - ✓ лецитин;
  - ✓ NAC;
  - ✓ курсами комплекс витаминов группы В при их дефиците.

Нужно регулярно заниматься желчеоттоком и выводить избыток билирубина. А также соблюдать диету.

Диета должна быть из белка с обязательным употреблением сырых овощей, зелени, ягод, фруктов. Важно, чтобы все основные приёмы пищи были ТЁПЛЫМИ (кроме салатов), как и напитки в течение дня.

ЕСЛИ:

- проводить регулярно желчегонные курсы;
- проводить детокс печени 2-3 раза в год (питаться от недели по схеме 3 фазы детоксификации печени);
- пропивать гепатопротекторы;
- соблюдать диету, не голодать;
- внимательно следить за питанием, включать в рацион вещества для стимуляции фермента;
- избегать вещества-блокаторы фермента;
- избегать интенсивную физическую активность;
- свести к минимуму недосып, голодания, усталость, стресс,

ТО СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА!

НУТРИЦЕВТИКИ ПРИ СИНДРОМЕ ЖИЛЬБЕРА:

(нужно принимать в комплексе на постоянной основе как указано на препаратах)

ТАУРИН (АМК) И Д-ГЛЮКАРАТ КАЛЬЦИЯ (calcium d-glucarate) – это две обязательные добавки при СЖ (снижают уровень общего и непрямого билирубина).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таурин нельзя приниматься при камнях в желчном пузыре и почках. Беременным можно принимать только по согласованию с гинекологом.

Д-ГЛЮКАРАТ КАЛЬЦИЯ можно принимать беременным и при камнях в желчном пузыре.

КУРКУМИН (с жирной пищей, с осторожностью при анемии).

Куркумин нельзя принимать беременным и при камнях в желчном пузыре.

ЛЕЦИТИН

Лецитин нельзя принимать при камнях в желчном пузыре, но можно беременным.

NAC

NAC нельзя принимать беременным и при камнях в желчном пузыре.

АЛЬФА ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА.

Альфа липоевую кислоту можно применять во время беременности и при камнях в желчном пузыре.

ЭКСТРАКТ БРОККОЛИ.

Экстракт семян брокколи можно принимать во время беременности после согласования с гинекологом. Данный нутрицевтик можно принимать при камнях в желчном пузыре.

+ ЖЕЛЧЕГОННЫЕ КУРСЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПРИ ОТСУТСТВИИ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что происходит в организме при СЖ?
2. К чему приводит СЖ?
3. Какой анализ нужно сдать, чтобы выявить СЖ? При каких симптомах его нужно сдать обязательно?
4. Как меняются печеночные пробы при СЖ?
5. Что означают результаты анализа на СЖ?
6. Какие симптомы СЖ?
7. Плюсы СЖ?
8. Что запускает обострение СЖ?
9. Какие виды СЖ вы знаете?
10. Какие органы и железы могут пострадать при СЖ?
11. Расскажите, как рекомендовано питаться людям с СЖ?
12. Какие вещества блокируют фермент, который переводит непрямой билирубин в прямой?
13. Какие вещества, наоборот, помогают активировать данный фермент?
14. Что нужно делать, чтобы СЖ не мешал качественно жить?
15. Какие нутрицевтики нужно назначить обязательно и пожизненно при СЖ, а какие нутрицевтики можно назначить дополнительно?